

INFILTRACIÓN DE RODILLA

Paula Leonor Vilorio Vecino, Julio Tito Camino Acha

INTRODUCCIÓN

La rodilla esta formada por:

- La articulación femoropatelar y tibiofemoral
- Estructuras periarticulares y ligamentos laterales

Material

- Gasas, guantes y campo estéril, povidona yodada, alcohol
- Jeringa de 5 y 10 ml.
- Aguja de 0,8 x 25 mm (21 G 1) (verde, intramuscular).
- Aguja de 0,9 x 25 mm (20 G 1)(Amarilla intravenoso/intramuscular)
- Parametasona 40 mg / 2 ml (Cortidene depot®)
- Triancinolona 40 mg / 1 ml (Trigon depot®)
- Betametasona 12 mg / 2 ml (Celestone Cronodose®)
- Anestésico local Mepivacaína 1% ó 2% sin vasoconstrictor: 2 ml

TÉCNICAS

Patologías intraarticulares

Infiltración intraarticular – artrocentesis

(ver capítulo correspondiente)

VÍAS

- **Vía suprapatelar lateral**
 - Punto de entrada: resulta de la intersección de dos líneas; una perpendicular al eje del muslo y situada a 1 cm. del polo superior de la rótula y la otra paralela al borde externo de la rótula separada de este también por 1 cm. de distancia.
 - Marcado el punto de cruce de ambas líneas introducimos la aguja perpendicular a la piel y paralela al plano de la camilla.
 - Con esta vía accedemos al resaca o bolsa suprapatelar, sin posibilidad de impactar contra la rótula.



Vía suprapatelar lateral

- **Vía lateral subrotuliana**

- Se empuja la rótula hacia la cara externa de la rodilla, al tiempo que se presiona la bolsa suprarotuliana.
- Punto de entrada: por debajo del alerón externo de la rótula a nivel de la interlinea femorotibial.
- Dirección de la aguja: perpendicular a la piel y paralela a la rótula e introduciéndola en su totalidad.



Vía lateral subrotuliana

- **Vía medial subrotuliana:**

- Punto de entrada: por debajo del alerón interno de la rotula a nivel de la unión de los dos tercios inferior con el tercio superior de la misma.
- Dirección de la aguja: perpendicular a la piel y paralela a la cara posterior de la rótula.
- La presión sobre el reseco suprapatelar facilitará la extracción del líquido.



Infiltración intraarticular para-rotuliana anterior

Paciente con rodilla flexionada

• COMPARTIMENTO EXTERNO

- Palpamos la interlínea articular.
- Punto de entrada: 1 cm lateral al tendón rotuliano y 1 cm superior a la interlínea.
- Dirección: perpendicular a la piel hacia el compartimento externo, paralela al plano del platillo tibial.
- En caso de encontrar resistencia o chocar con el cóndilo, reconducir la aguja.



Compartimento externo

• COMPARTIMENTO INTERNO

- Palpamos la interlínea articular.
- Punto de entrada: 1 cm medial al tendón rotuliano y 1 cm superior a la interlínea.
- Dirección: perpendicular a la piel hacia el compartimento interno, paralela al plano del platillo tibial.
- En caso de encontrar resistencia o chocar con el cóndilo, reconducir la aguja.



Compartimento interno

- **TENDINITIS DE LA PATA DE GANSO - BURSITIS ANSERINA**

- **Clínica:** dolor en cara interna de región proximal de tibia
- **Punto de entrada:** a nivel de la inserción de la pata de ganso (inserción distal de semitendinoso, sartorio y recto interno).
- **Dirección:** oblicua al plano cutáneo en dirección a los tendones de la pata de ganso. Infiltrar en forma de abanico en zona de máximo dolor.



Tendinitis de la pata de ganso - bursitis anserina

- **INFILTRACIÓN DEL MURO MENISCAL INTERNO**

- Útil en pacientes con clínica meniscal interna y dolor localizado.
- Paciente con la rodilla en flexión.
- **Punto de entrada:** a nivel de la interlínea articular posterointerna.
- **Dirección:** oblicua hacia la zona capsular posterointerna.



Infiltración del muro meniscal interno

- **BURSITIS PRE-ROTULIANA**

- Paciente en decúbito supino y rodilla en extensión.
- **Punto de entrada:** cara anterior de la rótula en su porción más externa.
- **Dirección:** oblicua, casi paralela a la piel, hasta llegar a la bursa.
- Tener en cuenta que hay que dirigir la aguja en varias direcciones, porque el derrame suele estar tabicado.



Bursitis pre-rotuliana